DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: MARIA MAGNOLIA SANCHEZ VASQUEZ **Identificación** CC 29900845
Edad: 61 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: QUIROFANO 5 **Fecha programación de cirugía:** 02/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**471102**	**APENDICECTOMIA VIA ABIERTA**	Y38	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**541701**	**LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA ABIERTA**	Y38	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**544104**	**OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA**	Y40	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**546101**	**CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVIS CERACION)**	Y40	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**547702**	**RETIRO DE DISPOSITIVO PARA CIERRE TEMPORAL DE PARED ABDOMINA L VIA ABIERTA**	Y40	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				
1	**867001**	**COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL HASTA DE DOS CENTIMETROS CUADRA DOS**	Y38	
Cirujano: DAVID MARTINEZ		**Especialidad:** CIRUGIA GENERAL		
Vía: ABDOMEN				

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ESP34 DAVID MARTINEZ **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

471102 **APENDICECTOMIA VIA ABIERTA**
541701 **LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA ABIERTA**
544104 **OMENTECTOMIA PARCIAL VIA ABIERTA**
546101 **CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVIS CERACION)**
547702 **RETIRO DE DISPOSITIVO PARA CIERRE TEMPORAL DE PARED ABDOMINA L VIA ABIERTA**
867001 **COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL HASTA DE DOS CENTIMETROS CUADRA DOS**

Dx Preoperatorio: K658 OTRAS PERITONITIS

Dx Postoperatorio: K658 OTRAS PERITONITIS

Tipo de Herida: SUCIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 02/11/26 **Fecha Final** 02/11/26
Hora Inicio 08:11:00 **Hora Final** 08:43:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
CONSENTIMIMENTO INFORMADO, PAUSA DE SEGURIDAD.
ANESTESIA GENERAL, RETIRO DE PELICULA ADHERENETE TRANSPARENTE DE LA PIEL , ASEPSIA Y ANTISEPSIA , SE COLOCA CAMPOS QUIRURGICOS.
RETIRO DE COMPRESAS HEMOSTATICAS NUMERO TOTAL 4.

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

SE REVISA CAVIDAD ABDOMINAL, NO SNGRADO ACTIVO, NO COLECCIONES, MUÑON DISTAL EN BUEN ESTADO.
SE PROCEDE REALIZAR LAAVADO PERITONEAL CON 2500 CC DE SOLKUION SALINA, A NIVEL DE MARCO COLICOS DRECHO E IZQUIERDO, AGUJERO PELVICO, DIAFRAGMA DERECHO E IZQUIERDO.
RETORNO DE LIQUIDO ADMINISTRADO DE CAARACTERISTICAS LIMPIOS.
SEGMENTO DE OMENTO MAYOR CON CAMPIOS NECITIOS, SE PROCVEDE A REALIZA RESECCION DE SEGMENTO AFECTADO, PINZA,LIGA Y CORTA, LIGADIRA D MUÑONES PROXIMALES DE EPIPLON CON SEDA 0. VRISFICA HEMOSTASIA,
SE REALIZA APENDICECTOMIA INCIDENTAL, DISECCION RETROGRADA, APENDICE IDENTIFICADA- PINZA,LIG Y CORTA , LIGADURA DE MUÑON DE BASE APENDICULAR CON SEDA 0.ELECTROFULGURACION DE MUCOSA DE MUÑON DE APENDICE CECAL CON ELECTROCAUTERIO.
PINZXA,LIGA Y CORTA MESO APENDIUALR, LOIGADURA DE MUÑON PROXIMAL CON SEDA 0.
LEVE SANGRADO POR CAPAS DE RETROPERITONEO IZQUIERDO, POR LO CUAL SE COLOCA MATERIAL HEMOSTAICO- SURGICEL FIBRILAR #1.
CONTEO COMPLETO DE CPOMPRSAS - DOCUMENTADO POR INSTRUMNTADORA Y AUXILIAR DE ENFERMERIA.
SE PROCEDE A CERRAR EVENTRACCION CONTENIDAD DE PARED ABDOMINL.
SE COLOCA DREN ABDOMINAL POR CONTRA ABERTURA A NIVEL DE LINEA AXILAR ANTERIIOR CON FOSA ILIACA DERECHA, SE FIJA A PIEL CON PROLENE 0. SE UBICA EN AGUJERO PELVICO.
SE TALLA COLGAJO LOCAL SIMPLE DE FASCIA DE 2 CM, PARA IDENTIFICAR FASCIA DE MEJOR CALIDAD Y CONSISTENCIA, SUTURA DE FASCIA CON VICRIL 11- PUNTOS CONTINUOS.
SE FIJA CICATRIZ UMBILICAL A FASCIA CON VICRIL 1, PUNTOS SUBCUTANESO CON VICRIL 2, SUTURA DE PIEL CON PROLENE 2/0 INTRADRMICOS.
SE COLOCAN APOSITOS LIMPIOS SOBRE HERIDA QUIRURGICA, SE FIJA A PIEL CON MICROPORE.

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

PACIENTE EN LAPAROSTOMIA CON SISTEM VAC
PERDIDAD DE CONTINUIDAD DE PIEL, TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO Y FASCIA DE APROXIMADAMENTE 15 X 6 CM (HERIUDA QUIRUGICA).
SE ENCUENTRA 4 COMPRESAS DE EMPAQUETAMIENTO, SE RETIRAR DE CAVIDAD ABDOMINAL.
COLOSTOMIA TIPO HARMAN , ESTOMA VITAL Y FUNCIONAL.
MUÑON DISTAL COLO RECTAL DISTAL, EN BUEN ESTADO, NO FUGAS NO SANGRADO.
SEGMENTO RESIDULA DE OMENTO MAYOR, SE OBSERVA CAMBIOS ISQUEMICOS EN TEJIDO DE APROXIMADAMENETE 15 X 10 CM, SE REALIZA OMENTECTOMIA PARCIAL.
FASCIA DE PARED ABDOMINAL, DELGADA, DE MALA CALIUDAD, SE DESGARA CON FACILIDAD AL RELIXZAR MANIOBRAS DE TRACCION.

LEVE SANGRADO POR CAPAS A NIVEL DE RETROPERITONEO IZQUIERDO CON FOSA ILICA IZQUIERDA, DISECADO, CO CONTROLADO CON ELECTROCAUTERIO, SE COLOCA MATERIAL HEMOSTATICO- SURGICEL FIBRTILAR #1.
SE REALÑIZA OMENTECTOMIA PARCIAL.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐

APENDICE CECAL.

PRODUCTO DE OMENTECTOMIA PARCIAL.

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES131	RUBEN DARIO LIBREROS	ANESTESIOLOGO
MG181	YULI ANDREA CRUZ ARANGO	AYUDANTE

David Martinez S.
CIRUGIA GENERAL
R.M. 502602
C.C. 79754801

DAVID MARTINEZ

Reg. 502602

CIRUGIA GENERAL

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***